

27

피부 발진

Skin rash

질환 이해 › 채점 역산 › 실전 실행 › 인출

감별 대책

전신 질환이 피부로 나타난 것인가, 피부 자체의 질환인가

보조축

원발진 형태 – 반점 · 구진 · 수포 · 농포 · 자반 · 팽진

관문

점막 침범 + 수포 + 니콜스키 › SJS/TEN / 입술 부종 · 호흡곤란 › 아나필락시스

가장 흔한 정답

아토피 피부염 · 접촉피부염 · 약물 발진

시간 예산

Hx 5분 / PEx 4분 / Edu 3분. 교육이 다른 CC보다 무거워요

이 CC의 함정

환자가 인지하지 못한 곳에 발진이 있는지 살피는 것. 옷과 장신구로 가려진 부위까지 봐야 해요

피부 발진은 보는 CC예요. 문진으로 좁히고 눈으로 확인하죠. 그래서 어디에서 처음 생겼고, 어디로 퍼졌고, 지금 어디에 있는지를 시간 순서로 받아내는 게 다른 어떤 CC보다 중요해요. 그리고 발진은 SP에게 분장으로 재현되어 있으니, 실제로 자세히 보고 만져야 합니다.

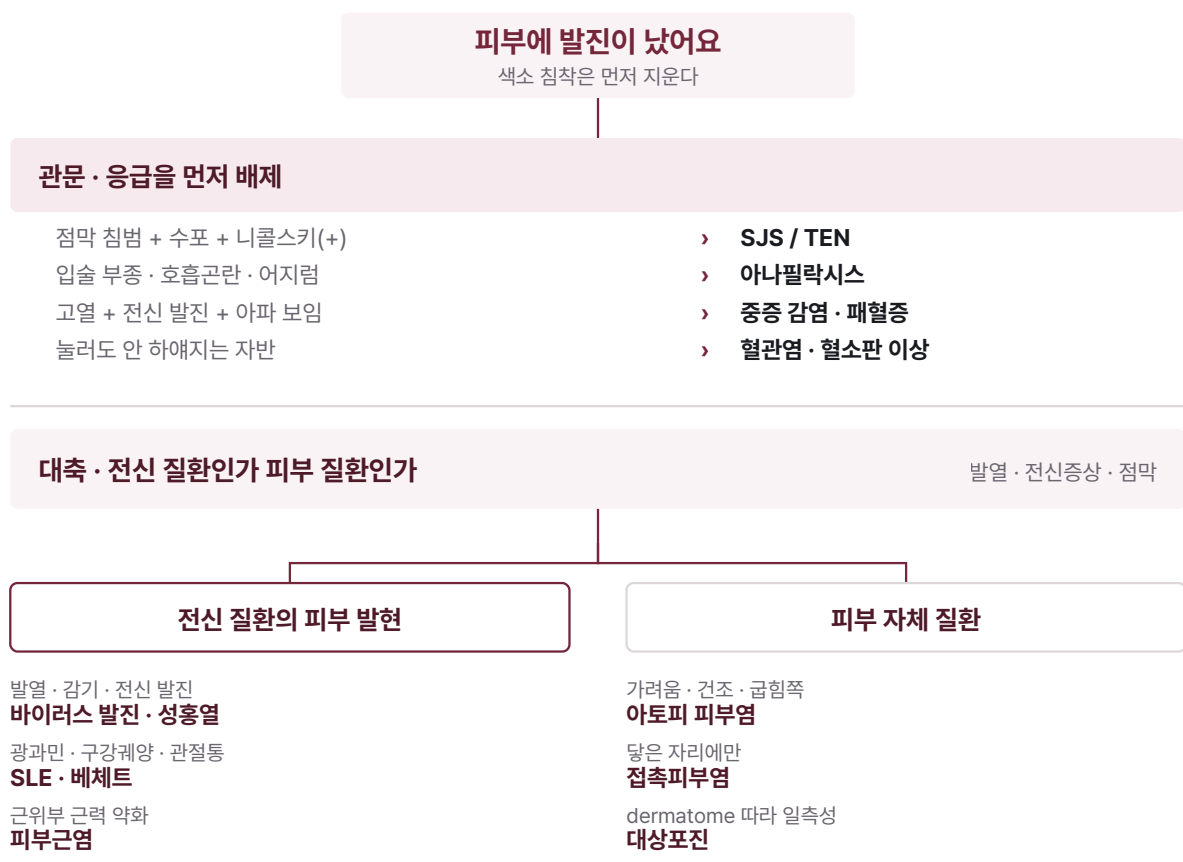
PART 0

이 CC에서 만나는 질환 지도

발진의 목록은 길어 보이지만, 첫 갈림길 하나가 절반을 잘라요. 피부만의 문제인가, 몸 전체 문제의 겉모습인가.

피부는 몸에서 가장 넓은 장기이면서 **다른 장기의 상태가 겉으로 드러나는 창**이에요. 그래서 발진을 만나면 늘 두 갈래를 동시에 봐야 해요. 피부에서 시작한 병인지, 아니면 전신 질환이 피부로 얼굴을 내민 건지.

이 구분이 왜 중요할까요? **치료의 대상이 완전히 달라지기 때문**이에요. 접촉피부염이면 원인 물질을 피하고 국소 치료로 끝나지만, 루푸스나 피부근염이면 피부만 치료해서는 아무 소용이 없거든요.



보조축은 원발진 형태 – blanching / 자반 / 수포 / 농포

응급을 먼저 지우고, 전신인지 피부인지 가른 다음, 원발진 형태로 좁힌다

0-1. 질환들의 첫인상

덩어리	질환	환자가 보이는 모습
전신 · 감염	바이러스 발진	열이 나고 감기 증상이 있다가 발진이 났어요. 얼굴에서 시작해 몸통으로 퍼져요
전신 · 감염	성홍열	세 살 넘는 아이가 고열과 인후통, 구토가 있고 온몸에 발진이 났어요
전신 · 감염	2기 매독	열과 감기 증상이 있고 손바닥 발바닥까지 발진이 났어요. 최근 위험한 성관계가 있었어요

덜어리	질 환	환자 가 보 이 는 모습
전신 · 자가면역	전신홍반루푸스	뺨에 나비 모양 발진이 있고 햇빛을 보면 심해져요. 구강 궤양과 관절통, 거품뇨도 있어요
전신 · 자가면역	베체트병	입안과 성기에 궤양이 반복되고 눈이 아파요. 관절도 아프고요
전신 · 자가면역	피부근염	눈꺼풀이 보랏빛으로 붓고 손가락 마디에 발진이 있어요. 머리 빗기와 계단 오르기가 힘들어요
피부 · 감염	대상포진	한쪽에만 띠처럼 물집이 났어요. 발진 전부터 그 자리가 아팠고요. 나이가 많거나 면역이 떨어져 있어요
피부 · 감염	옴	밤에 유난히 가려워요. 사타구니와 겨드랑이가 심하고 가족도 같이 가려워해요
피부 · 감염	어루러기	땀이 많이 나는 가슴과 등에 얼룩덜룩한 반점이 있어요. 별로 안 가렵고요
피부 · 염증	건선	팔꿈치와 무릎에 은백색 비늘이 겹겹이 덮인 판이 있어요. 손발톱도 변했고요
피부 · 알레르기	접촉피부염	새 화장품을 쓴 자리에만, 벨트가 닿는 자리에만 발진이 났어요
피부 · 알레르기	아토피 피부염	어릴 때부터 가렵고 건조해요. 팔오금 · 무릎 뒤가 심하고 알레르기 비염도 있어요
피부 · 의인성	약물 발진	약을 먹고 며칠 뒤 온몸에 발진이 났어요. 예전에도 같은 자리에 났던 적이 있고요

스스로 답해 보기

- Q** 피부 발진의 첫 갈림길은 무엇이고, 그 구분이 왜 치료를 바꾸는가?
Q 관문에 들어가는 응급 네 가지는?

PART 1

대축과 관문

대축은 전신인가 피부인가, 보조축은 원발진 형태예요. 그 앞에 응급을 거르는 관문이 놓여요.

1-1. 왜 전신인가 피부인가가 대축일까요?

이유는 셋이에요. 첫째, **질문 몇 개로 판정돼요**. 발열이 있나, 점막이 침범됐나, 관절통이나 근력 저하가 있나. 둘째, **치료 대상이 통째로 갈려요**. 셋째, **놓쳤을 때의 대가가 달라요**. 피부 질환을 전신으로 오인하면 검사가 늘 뿐이지만, 전신 질환을 피부로 오인하면 원인 질환이 계속 진행해요.

반대로 원발진 형태를 대축으로 삼으면 안 되는 이유도 분명해요. 같은 수포가 대상포진에서도 나오고 SJS/TEN에서도 나오고 천포창에서도 나오거든요. 형태는 후보를 좁히는 **보조축**이지 첫 갈림길이 아니에요.

문서 전체에서 계속 돌아올 질문 – 이 발진이 피부에서 시작한 것인가, 아니면 몸 전체 문제의 걸모습인가.

1-2. 관문 – 응급 넷을 먼저 지워요

점막 침범 + 수포 + 니콜스키 양성 SJS/TEN. 피부가 벗겨지는 상태라 화상처럼 다뤄요. **관문**

입술 부종 · 호흡곤란 · 어지럼 · 두근거림 아나필락시스. 에피네프린이 필요해요. **관문**

고열 + 전신 발진 + 아파 보임 중증 감염. 수막알균 감염 같은 경우예요. **관문**

눌러도 안 하얘지는 자반 혈관염이나 혈소판 이상. 혈관 밖으로 피가 나온 상태예요. **관문**

이 넷은 발진의 모양을 열심히 묘사하기 전에 먼저 확인해요. 특히 **점막**이 중요해요. 입 안, 눈, 성기에 병변이 있으면 그것만으로 심각도가 한 단계 올라가거든요. 그래서 진찰에서 눈 · 구강을 먼저 보게 되어 있어요.

1-3. 보조축 – 원발진 형태

대축을 통과하면 형태로 좁혀요. **만저지는가, 눌러서 하얘지는가, 액체가 찢는가**. 이 세 질문이 형태를 결정해요.

원발진	무엇인가	대표 질환
반점 macule	만져지지 않는 색 변화	어루러기 · 약물 발진 초기
구진 papule	만져지는 작은 융기	건선 초기 · 벌레 물림
판 plaque	구진이 뭉쳐 넓어진 것	건선 · 만성 아토피
수포 vesicle	맑은 액이 찬 물집	수두 · 대상포진 · 한포진
농포 pustule	고름이 찬 물집	여드름 · 농포성 건선
자반 purpura	눌러도 안 하얘지는 출혈	혈관염 · 혈소판 이상
팽진 wheal	부풀었다 몇 시간 내 사라짐	두드러기

이차 병변 – 딱지 · 비늘 · 태선화 · 미란은 원발진이 시간을 지나며 변한 결과다.

원발진 여섯 가지. 이차 병변은 원발진이 시간을 지나며 변한 결과다

1-4. 실제로 헛갈리는 두 쌍

홍반 vs 자반

둘 다 붉어요. 그런데 **눌러 보면 갈려요**. 홍반(erythema)은 혈관이 확장된 것이라 누르면 피가 밀려나가 하얘졌다가 떼면 다시 붉어져요. 자반(purpura)은 혈관 밖으로 피가 새어 나온 것이라 **눌러도 그대로**예요.

그래서 이 구분이 진찰 항목에 들어 있어요. 누르는 것만으로 혈관염이나 혈소판 이상 같은 전신 질환 쪽으로 방향을 틀 수 있거든요. 쉽게 말하면 **물감이 물에 풀린 것인지 종이에 스며든 것인지**를 보는 셈이에요.

접촉피부염 vs 아토피 피부염

둘 다 가렵고 붉고 진물이 날 수 있어요. 갈라주는 건 **분포**예요. 접촉피부염은 **닿은 자리에만** 경계가 뚜렷하게 생겨요. 벨트 자리, 목걸이 자리, 화장품 바른 자리처럼요. 아토피는 **정해진 호발 부위**에 생겨요. 2세 미만은 얼굴 · 몸통 · 사지 편쪽, 2세 이상은 얼굴 · 목 · 사지 굽힘쪽이에요.

스스로 답해보기

Q 홍반과 자반을 가르는 진찰 동작 하나는? 그게 왜 전신 질환을 지목하는가?

Q 접촉피부염과 아토피 피부염을 가르는 축은?

PART 2

최소 기초 세 덩어리

2-1. 피부는 벽이고, 그 벽이 새면 가려워져요

피부 맨 바깥층은 벽돌과 시멘트 같은 구조예요. 각질세포가 벽돌이고 지질이 시멘트죠. 이 벽이 물은 안 나가게 막고 밖의 자극물과 알레르겐은 못 들어오게 막아요.

아토피 피부염에서는 이 **벽이 태생적으로 새요**. 그러니 수분이 빠져나가 건조해지고, 알레르겐이 쉽게 들어와 면역 반응이 일어나요. 가려워서 긁으면 벽이 더 망가지고, 더 새고, 더 가려워지죠. **가려움과 긁기가 서로를 키우는 고리**가 생기는 거예요.

그래서 치료의 축이 두 개예요. **보습으로 벽을 메우고, 긁지 않게 해서 고리를 끊는 것**. 스테로이드는 이미 붙은 불을 끄는 역할이고, 벽을 고치는 건 보습제예요.

› 이 개념은 3-1 아토피 피부염, PART 6의 F 항목, PART 9의 생활교육에서 회수돼요.

2-2. 눌러서 하얘지는가 - 피가 어디 있느냐의 문제

피부가 붉게 보이는 이유는 두 가지뿐이에요. **혈관 안에 피가 많거나, 혈관 밖으로 피가 나왔거나**. 혈관이 확장되어 붉으면 누를 때 피가 옆으로 밀려나 하얘져요. 혈관 밖으로 새어 나온 피는 밀 곳이 없으니 그대로 남고요.

이 단순한 물리가 진단을 크게 갈라요. 눌러도 안 하얘진다는 건 **혈관벽이 새고 있다**는 뜻이고, 그러면 혈관염이나 혈소판 문제 같은 전신 질환을 봐야 하거든요.

쉽게 말하면 **물에 푼 물감은 밀리고, 종이에 스민 물감은 안 밀리는** 셈이에요.

› 이 개념은 1-4의 혼동쌍, PART 7의 압통 촉진과 diascopy, PART 1의 관문 자반 항목에서 회수돼요.

2-3. 신경 하나를 따라 띠처럼 - dermatome

척수에서 나온 감각신경 하나가 담당하는 피부 구역을 **dermatome**이라고 해요. 띠처럼 몸을 두르고 있고, 몸 한쪽만 담당해요. 반대쪽은 반대쪽 신경이 담당하거든요.

수두 바이러스는 처음 감염 뒤 신경절에 숨어 있다가, 면역이 떨어지면 다시 깨어나 그 신경을 타고 피부로 나와요. 그래서 대상포진은 **한쪽에만, 띠처럼** 생겨요. 그리고 신경을 타고 나오는 병이니 **발진보다 통증이 먼저** 옵니다.

이 두 특징 - 일측성과 선행 통증 - 이 대상포진을 다른 수포성 질환과 갈라줘요. 접촉피부염이나 한포진은 양쪽에 생기고 통증이 먼저 오지 않거든요.

› 이 개념은 3-4 대상포진, PART 6의 L 항목, PART 7의 분포 사진에서 회수돼요.

스스로 답해보기

- Q 아토피에서 보습제가 스테로이드만큼 중요한 이유는?
- Q 눌러도 안 하얘지는 발진이 왜 전신 질환을 지목하는가?
- Q 대상포진이 한쪽에만 띠처럼 생기는 이유는?

PART 3

핵심 질환 한 바퀴

여섯만 돌려요. 가장 흔한 셋, 특징이 뚜렷한 감염 둘, 그리고 소아 하나.

3-1. 아토피 피부염

왜 건조하고, 왜 가렵고, 왜 긁힘쪽일까요?

환자

어릴 때부터 피부가 건조하고 가려웠어요.
요즘은 팔오금이랑 무릎 뒤가 특히 심해요. 긁으면 진물이 나고요.
밤에 더 가려워서 잠을 설칩니다.
알레르기 비염도 있고, 어머니도 천식이 있으세요.

결정적인 건 **만성·가려움·건조·긁힘쪽·알레르기 가족력**이에요. 다섯이 모이면 거의 확정이고, 특히 **어릴 때부터**라는 시간 축이 급성 질환들을 지워요.

왜 건조할까요?

PART 2-1의 벽 이야기예요. 각질층의 지질과 단백질 구조가 약해서 **수분이 계속 빠져나가요**. 그래서 아무리 물을 발라도 금방 마르고, 지질을 채워 주는 보습제가 필요해요.

왜 가려움과 긁기가 악순환일까요?

벽이 새면 알레르겐이 쉽게 들어와 면역 반응이 일어나고, 그 결과 가려워져요. 긁으면 벽이 더 망가지고, 더 새고, 더 가려워지죠. 게다가 긁힌 자리로 세균이 들어와 이차 감염이 생기기도 하고요. **고리를 끊는 게 치료의 절반**이라 긁지 말라는 교육이 약 처방만큼 중요해요.

왜 나이에 따라 부위가 바뀔까요?

2세 미만은 **얼굴·몸통·사지 편쪽**, 2세 이상은 **얼굴·목·사지 긁힘쪽**이에요. 아기는 기어 다니며 편쪽이 바닥에 닿고 침이 얼굴에 묻어요. 크면서는 땀이 고이고 마찰이 반복되는 긁힘쪽이 주 무대가 되고요. **나이를 물어야 부위 해석이 됩니다**.

왜 밤에 더 가려울까요?

밤에는 체온이 오르고 피부 혈류가 늘어 가려움 역치가 낮아져요. 그리고 낮처럼 주의를 분산시킬 자극이 없으니 가려움이 더 크게 느껴지고요. 그래서 수면 방해가 심하고, 항히스타민제가 밤에 특히 도움이 돼요.

왜 알레르기 가족력을 물을까요?

아토피 피부염·알레르기 비염·천식은 같은 소인을 공유해요. 본인에게 비염이나 천식이 있거나 가족에게 있으면 사전 확률이 크게 올라가요. 그래서 과거력과 가족력이 이 질환에서 유난히 무거워요.

쌍둥이 감별 - 접촉피부염. 둘 다 가렵고 진물이 나요. 갈라주는 건 **닿은 자리에만 생기나요, 아니면 늘 같은 부위에 생кина요**예요.

CPX 연결. O에서 어릴 때부터라는 만성 경과를 잡고 › L에서 굽힘쪽 분포를 확인하고 › C에서 가려움과 건조를 받아 내고 › 과에서 비염 · 천식을, 가에서 알레르기 가족력을 묻고 › PEx에서 전신 시진과 **피부요기증** 확인 › 검사는 skin prick test와 혈청 IgE › Edu에서 보습 · 증성비누 · 긁지 않기를 설명해요.

SP 언어 사인 어릴 때부터 그랬어요 · 팔오금이 심해요 · 밤에 더 가려워요 · 긁으면 진물이 나요 · 비염도 있어요

3-2. 접촉피부염

왜 닿은 자리에만 생길까요?

환자

새로 산 목걸이를 하고부터 목에 발진이 났어요.

목걸이가 닿는 자리만 딱 붉어지고 가려워요.

안 하면 좀 가라앉았는데 다시 하면 또 생겨요.

결정적인 건 **경계가 뚜렷한 국소 분포 + 노출과의 시간 관계**예요. **닿은 자리에만**이라는 말이 나오면 이 진단이 거의 확정돼요.

왜 경계가 뚜렷할까요?

원인 물질이 닿은 곳에서만 면역 반응이 일어나기 때문이에요. 물질이 퍼지지 않으니 병변도 퍼지지 않고, 접촉면의 모양을 그대로 따라가요. 벨트 자국, 시겟줄 자국, 화장품 바른 범위처럼요. 쉽게 말하면 **도장이 찍힌 모양**인 셈이에요.

왜 처음 쓸 때는 괜찮았을까요?

알레르기성 접촉피부염은 **감작**이 필요해요. 처음 노출에서는 면역계가 그 물질을 기억만 하고, 다시 만났을 때 반응해요. 그래서 오래 쓰던 화장품에도 어느 날 갑자기 발진이 날 수 있어요. **새로 바꾼 것만 묻고 끝내면 놓쳐요.**

왜 첩포검사를 할까요?

의심 물질을 등에 붙여 놓고 며칠 뒤 반응을 보는 검사예요. 무엇이 원인인지 알아야 피할 수 있고, **회피가 곧 치료**이기 때문에 원인 규명이 중요해요. 판독은 부착 후 2일째와 4일째에 해요.

쌍둥이 감별 - 아토피 피부염. 갈라주는 건 분포예요. **닿은 자리에만인가, 정해진 호발 부위인가.**

CPX 연결. L에서 병변 경계와 모양을 확인하고 › F 접촉피부염에서 새로운 비누 · 화장품 · 로션 · 옷을 묻고 › Ex에서 이전에도 같은 상황이 있었는지 확인하고 › PEx에서 분포와 경계를 시진 › 검사는 첩포검사와 유발검사 › Edu에서 원인 회피와 냉습포, 국소 스테로이드를 설명해요.

SP 언어 사인 닿는 자리만 그래요 · 새로 산 걸 쓰고부터요 · 안 하면 가라앉아요 · 경계가 뚜렷해요

3-3. 약물 발진

왜 며칠 뒤에 나고, 왜 같은 자리에 또 날까요?

환자

감기약을 먹고 사나흘 뒤에 온몸에 발진이 났어요.

가렵고 붉은 반점이 여기저기 있습니다.

예전에도 약 먹고 이 자리에 똑같이 난 적이 있어요.

결정적인 건 **약물 노출 + 시간 지연 + 전신 분포**예요. 그리고 **같은 자리에 반복**된다는 말이 나오면 고정 약진을 떠올려요.

왜 바로가 아니라 며칠 뒤일까요?

대부분의 약물 발진은 지연형 면역 반응이라 **T세포가 활성화되는 데 며칠이 걸려요**. 그래서 약을 먹은 지 며칠 뒤에 나타나고, 환자는 약과 연결 짓지 못하는 경우가 많아요. 묻지 않으면 안 나오는 정보라는 뜻이에요.

왜 고정 약진은 같은 자리에 날까요?

그 부위 피부에 기억 T세포가 남아 있기 때문이에요. 같은 약이 들어오면 그 자리에서만 다시 반응하고, 가라앉은 뒤에는 **과색소 침착**이 남아요. 그래서 예전 흔적이 같은 자리에 보이는 게 단서가 됩니다.

왜 약을 끊는 게 첫 치료일까요?

원인이 계속 들어오는 한 반응이 멈추지 않기 때문이에요. 의심되는 약을 중단하고 반응을 보는 것이 진단이자 치료예요. 그 다음이 스테로이드와 항히스타민제고요. **전신 증상이 있으면 전신 스테로이드**로 올라가요.

언제 응급으로 넘어갈까요?

점막이 침범되거나 수포가 생기고 니콜스키 징후가 양성이면 SJS/TEN이에요. **이건 단순 약진이 아니라 피부가 벗겨지는 상태라 화상처럼** 다뤄야 해요. 그래서 약물 발진 케이스에서는 입 안과 눈을 반드시 봅니다.

쌍둥이 감별 - 바이러스 발진. 둘 다 전신에 붉은 반점이 나요. 갈라주는 건 **약을 새로 드셨나요**와 **발열과 감기 증상이 먼저 왔나요**예요.

CPX 연결. 약에서 최근 새로 먹은 약과 건강보조식품을 묻고, O에서 복용과 발진의 시간 간격을 잡고, Ex에서 같은 자리 반복을 확인하고, PEx에서 구강·눈 점막과 니콜스키 징후, 검사는 의심 약 중단, 고정 약진이면 철폐검사, Edu에서 약물 중단 후 반응 확인과 아나필락시스 교육을 해요.

SP 언어 사인 약 먹고 며칠 뒤예요 · 온몸에 났어요 · 예전에도 같은 자리에 났어요

3-4. 대상포진

왜 한쪽에만 띠처럼 나고, 왜 발진보다 통증이 먼저일까요?

환자

일흔두 살입니다. 사흘 전부터 오른쪽 옆구리가 따끔따끔 아팠어요.

어제부터 그 자리에 물집이 띠처럼 줄지어 났습니다.

반대쪽은 아무렇지도 않아요.

결정적인 건 **일측성 + dermatome 분포 + 선행 통증**이에요. 셋이 모이면 다른 수포성 질환과 거의 겹치지 않아요.

왜 한쪽에만 날까요?

PART 2-3의 dermatome 이야기예요. 바이러스가 **신경절 하나에서 깨어나** 그 신경을 타고 나오니까, 그 신경이 담당하는 한쪽 띠에만 병변이 생겨요. 반대쪽은 다른 신경이 담당하니 멀쩡하고요.

왜 통증이 먼저 올까요?

바이러스가 신경 안에서 증식하면서 신경 자체를 자극하기 때문이에요. 그래서 **피부에 나오기 2~3일 전부터 그 구역이 아프거나 따끔거려요**. 발진이 없는 이 시기에 오면 진단이 어려운데, 일측성이라는 것과 나이가 단서가 돼요.

왜 노인과 면역저하자에게 올까요?

바이러스는 계속 신경절에 숨어 있고, 세포성 면역이 그걸 눌러 두고 있어요. 나이가 들거나 면역이 떨어지면 **누르는 힘이 약해져** 바이러스가 다시 활동해요. 그래서 젊은 사람에게 오면 면역저하 상태를 한 번 의심해 봐야 해요.

왜 통증 조절을 따로 챙길까요?

신경이 손상되는 병이라 **발진이 나온 뒤에도 통증이 남을 수 있어요**. 그래서 항바이러스제와 별도로 진통 계획을 세워요. NSAID로 시작해 필요하면 opioid, 신경병증성 통증에는 항우울제와 항경련제를 씁니다.

쌍둥이 감별 - 접촉피부염 · 한포진. 갈라주는 건 **한쪽인가 양쪽인가**와 **발진 전에 아팠나요**예요.

CPX 연결. L에서 일측성과 띠 모양 분포를 확인하고, O에서 통증이 발진보다 먼저였는지 잡고, 과에서 면역저하 상태를 묻고, PEx에서 dermatome 분포와 수포 · 딱지 확인, 검사는 대개 불필요, 간혹 PCR, Edu에서 항바이러스제와 통증 조절, 신경통이 남을 수 있음을 설명해요.

SP 언어 사인 한쪽만 그래요 · 띠처럼 줄지어 났어요 · 발진 나기 전부터 아팠어요 · 따끔따끔해요

3-5. 옴

왜 밤에 가렵고, 왜 가족이 같이 가려울까요?

환자

두 주 전부터 온몸이 가려운데 밤에 유난히 심해요.
사타구니랑 겨드랑이, 손가락 사이가 제일 가렵습니다.
같이 사는 아들도 요즘 가렵다고 해요.

결정적인 건 **야간 가려움 + 특정 부위 + 가족 동시 발생**이에요. 세 번째가 특히 강력해요. 다른 피부 질환은 가족이 동시에 가렵지 않거든요.

왜 밤에 심할까요?

진드기가 밤에 활동적이 되고, 몸이 따뜻해지면 움직임이 더 활발해져요. 그리고 낮과 달리 주의를 분산시킬 게 없으니 가려움이 더 크게 느껴지고요. **밤에 유난히**라는 말이 나오면 옴을 목록에 올려요.

왜 사타구니 · 겨드랑이 · 손가락 사이일까요?

진드기는 각질층이 얇고 따뜻하며 습한 곳을 좋아해요. 손가락 사이, 손목 안쪽, 겨드랑이, 사타구니, 성기 주변이 그런 자리죠. 그 자리에 **굴**을 파고 들어가는데, 이 굴을 찾는 게 진찰의 핵심이에요.

왜 가족을 같이 치료할까요?

사람 사이 밀접 접촉으로 옮기기 때문이에요. 한 사람만 치료하면 **서로 다시 옮겨 끝나지 않아요**. 그래서 증상이 없어도 같이 사는 사람 전부를 동시에 치료해요. 이게 이 질환 교육의 핵심이에요.

왜 얼굴은 빼고 바를까요?

퍼메트린 연고는 얼굴을 제외하고 목 아래 전신에 바르고 8시간 뒤에 씻어내요. 성인에서는 얼굴에 잘 생기지 않고, 눈과 점막 자극을 피하기 위해서예요.

쌍둥이 감별 - 아토피 피부염. 둘 다 가려워요. 갈라주는 건 **가족도 같이 가려운가요**와 **밤에 유난히 심한가요**예요.

CPX 연결. C에서 가려움의 정도와 밤낮 변화를 받아내고, L에서 사타구니·겨드랑이 분포를 확인하고, 가에서 가족 중 같은 증상을 묻고, PEx에서 손가락 사이·손목 안쪽·성기의 굴 확인, 검사는 병변을 긁어 현미경, Edu에서 가족 동시 치료와 도포 방법을 설명해요.

SP 언어 사인 밤에 유난히 가려워요·사타구니가 심해요·아들도 가렵대요·손가락 사이가 가려워요

3-6. 성홍열

왜 인후통이 먼저이고, 왜 소아일까요?

보호자

다섯 살 아이인데 이틀 전부터 열이 많이 나고 목이 아프다고 해요.

먹지를 못하고 토했어요.

어제부터 몸에 붉은 발진이 오돌토돌하게 돋았습니다.

결정적인 건 **3세 이상 소아 + 고열·인후통·구토 + 전신 발진**이에요. 발진보다 **인후통이 먼저**라는 시간 순서가 특징이에요.

왜 목에서 시작할까요?

원인균이 인두에 자리 잡아 인두염을 일으키고, 균이 만든 독소가 혈류를 타고 돌면서 피부에 발진을 만들기 때문이에요. **감염은 목에, 발진은 독소 때문에 전신에** 생기는 구조예요. 그래서 인후통과 발열이 먼저고 발진이 나중이에요.

왜 3세 이상일까요?

독소에 대한 면역이 없어야 발진이 나는데, 아주 어린 영아는 모체 항체가 남아 있고 성인은 대개 면역이 생겨 있어요. 그래서 **3세 이상 소아가 호발 연령**이에요.

왜 중심에서 주변으로 퍼질까요?

혈류를 타고 온 독소가 몸통의 굵은 혈관 주변에서 먼저 반응을 만들기 때문이에요. 그래서 몸통에서 시작해 팔다리로 퍼지고, 접히는 부위에서 더 진해져요. 바이러스 발진도 같은 이유로 중심부에서 주변부로 퍼져요.

왜 항생제를 쓸까요?

세균 감염이라 항생제가 듣기도 하고, 치료하지 않으면 이후 합병증이 남을 수 있기 때문이에요. 진단은 임상 증상과 병력으로 하고, 확인이 필요하면 **편도와 인두에서 검체를 채취해 균 배양**을 해요.

쌍둥이 감별 - 바이러스 발진. 둘 다 열과 전신 발진이에요. 갈라주는 건 **인후통과 구토가 두드러지냐**와 발진의 질감이에요.

CPX 연결. A 전신에서 발열을, A 감염에서 인후통·구토를 받아내고, O에서 인후통이 발진보다 먼저였음을 확인하고, L에서 중심에서 주변으로 퍼진 순서를 잡고, PEx에서 인두·편도와 경부 림프절, 검사는 임상 진단 + 균 배양, Edu에서 항생제 복용과 전파 방지를 설명해요.

SP 언어 사인 열이 많이 나요·목이 아파서 못 먹어요·토했어요·어제부터 몸에 발진이 났어요

3-7. 나머지는 결정 단서만

질환	덩 어리	결정 단서	검사 · 치료
바이러스 발진	전신 · 감 염	발열, 감기 증상, 홍역 3C, 중심부에서 주변부로 퍼짐. 수두는 다양한 형태가 섞임	CBC · 혈청검사 / 대증 치료, 성인 수두는 항바이러스제
2기 매독	전신 · 감 염	발열, 감기 증상, 전신 발진, 위험한 성관계 . 외음부 궤양 병력은 없을 수 있음	VDRL · TPHA · FTA-ABS / Benzathine penicillin
어루러기	피부 · 감 염	땀이 많이 나는 가슴 · 등 · 겨드랑이에 얼룩덜룩한 흰색 · 갈색 반점, 대개 무증상	우드등검사 · KOH 도말 · 진균배양 / 건조하고 시원한 환경, 국소항진균제
건선	피부 · 염 증	구진이 뭉쳐 판이 되고 은백색 비늘이 겹겹이 . 팔꿈치 · 엉덩이 · 두피, 손발톱 변화	피부조직검사 · 임상 진단 / 보습, 국소 스테로이드, 광선 치료, Retinoid
전신홍반루푸스	전신 · 자 가면역	malar rash, discoid rash, 광과민성, 구강 궤양, 관절염, 거품뇨	CBC · 항핵항체 · anti-dsDNA / 국소 스테로이드, HCQ, Glucocorticoid
베체트병	전신 · 자 가면역	구강 궤양 + 생식기 궤양 + 포도막염 + 관절염	Pathergy test, 결절성 홍반 / Colchicine(피부), Glucocorticoid
피부근염	전신 · 자 가면역	gotttron papule, heliotrope rash. 머리 빗기와 계단 오르기가 힘들다	EMG · CK · 근육조직검사 / 국소 · 전신 스테로이드, 면역억제제

3-8. 발진의 시간 순서로 다시 정리

발진 CC에서 자주 승부가 나는 건 **무엇이 먼저 왔는가**예요. 같은 전신 발진이라도 앞에 뭐가 왔느냐로 갈려요.

먼저 온 것	그 다음	가리키는 것
발열 · 감기 증상	전신 발진	바이러스 발진 · 2기 매독
고열 · 인후통 · 구토	전신 발진	성홍열
약물 복용	며칠 뒤 전신 발진	약물 발진
한쪽 부위 통증	2~3일 뒤 그 자리에 수포	대상포진
새 물질 접촉	닿은 자리에만 발진	접촉피부염
아무것도 없음	어릴 때부터 만성 가려움	아토피 피부염

스스로 답해보기

- Q 아토피에서 나이에 따라 부위가 바뀌는 이유는?
- Q 접촉피부염에서 오래 쓰던 물건도 원인이 될 수 있는 이유는?
- Q 대상포진에서 통증이 발진보다 먼저인 기전은?
- Q 옴에서 가족을 동시에 치료하는 이유는?

PART 4

채점 역산표

발진은 위치와 시간 순서가 배점의 중심이에요.

4-1. MUST

L 세 단계 어디에서 처음 › 어디로 퍼졌고 › 지금 어디에. 이 CC의 핵심이에요. **MUST**

C 양상 모양 · 수 · 크기 · 색깔 · 딱지 · 물질 · 흰비늘. **MUST**

C 동반 열감 · 가려움증 · 따가움 · 압통(HIT). **MUST**

A 전신 발열 · 오한 · 감기 기운 · 근육통 · 관절통. **MUST**

A 류마티스 광과민 · 거품뇨 · 구강 · 성기 궤양 · 근력 약화. **MUST**

A 알레르기 입술 부종. 아나필락시스를 거르는 항목이에요. **MUST**

약 최근 새로 먹은 약과 건강보조식품, 중단 시 호전 여부. **MUST**

F 접촉 새로운 비누 · 화장품 · 로션 · 옷이 닿았는지. **MUST**

과 · 가 알레르기 천식 · 비염 · 아토피와 그 가족력. **MUST**

4-2. SHOULD와 DROP

등급	항목	왜 그 등급인가
SHOULD	F 음식 · 콜린성 · 위험한 성관계	해당 방향으로 기울 때 결정적이에요
SHOULD	D 지속 · 빈도 · 밤낮 변화	밤에 심하면 옴, 몇 시간 내 사라지면 두드러기
SHOULD	Co 크기 · 개수 · 증상 진행	진행 속도가 급성 감염과 만성 질환을 갈라요
SHOULD	Ex 이전 삽화 · 피부과 치료	만성 반복인지, 치료 반응이 어땠는지
SHOULD	사 여행 · 벌레 물림 · 직업	감염과 노출 경로를 잡아요
SHOULD	A 감염 계통	오심 · 구토 · 설사 · 호흡기 증상
DROP	E 건강검진	감별을 못 줍혀요
DROP	외 수술력	이 CC에서 기여가 약해요
DROP	여 월경력 세부	질분비물과 성관계 시 통증은 매독 · 성병 방향에서만 의미

버리는 순서는 E › 외 › 여 월경 세부 › Co예요.

PART 5

문진 개관

발진 문진의 중심은 L이에요. 위치를 시간 순서로 받아내는 것.

다른 CC에서 L은 아픈 곳을 확인하는 항목이에요. 발진에서는 다릅니다. **어디에서 처음 생겼고, 어디로 퍼졌고, 지금 어디에 있는가** - 세 단계를 시간 순서로 받아야 해요. 이게 곧 **발진의 진행 경로**이고, 경로가 진단을 만들어요.

중심부에서 주변부로 퍼졌으면 혈류를 타고 온 것이니 전신 감염이고, 한 자리에서 안 움직이면 접촉이나 국소 병변이고, 띠처럼 한쪽으로만 가면 신경을 탄 거예요. **경로가 기전을 말해 줍니다.**

C도 다른 CC와 달라요. 통증의 양상이 아니라 **병변의 생김새**를 받아요. 모양 · 수 · 크기 · 색깔이 기본이고, 여기에 딱지 · 물집 · 흰비늘 같은 이차 변화를 더해요. 그리고 동반 증상 셋 - 열감 · 가려움 · 압통 - 을 붙이고요.

A는 대축을 판정해요. **전신 증상이 있으면 전신 질환**이거든요. 발열 · 근육통 · 관절통이 있으면 감염이나 자가면역 쪽으로, 없으면 피부 자체 질환 쪽으로.

문진의 뼈대 한 줄 - L로 경로를 그리고, C로 생김새를 받고, A로 전신인지 피부인지 가른다.

5-1. 암기법 두 개

항목 암기법 풀이

C 양상 **복송** 딱지 > 딱딱 복송아 · **물집** > 물렁 복송아 · **흰비늘** > 복송아 껍질. 여기에 기본 넷을 더해요 - 수(count) · 크기(size) · 색깔(color) · 모양(shape), c/s/c/s

C 동반 **HIT** **H**ot 열감 · **I**tch 가려움 · **T**enderness 압통. 따가움은 가려움과 같이 물어봐요

PART 6

History taking

6-1. O – 언제, 어떤 상황에서

O 발생 MUST

언제부터 피부에 발진이 났나요? 어떤 특별한 상황에서 발생했나요?

시작 시점과 계기를 동시에 받아요. 약 복용 · 새 물질 접촉 · 감염 · 음식 중 무엇이 앞에 있었는지가 갈려요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
약 먹고 며칠 뒤	약물 발진	지연형 면역 반응이라 T세포 활성화에 며칠이 걸린다
새 물건을 쓴 뒤	접촉피부염	감작된 물질에 다시 노출되면 그 자리에서 반응한다
열과 감기 증상 뒤	바이러스 발진 · 성홍열 · 2기 매독	감염이 먼저 오고 발진이 뒤따른다
한쪽이 아프고 나서	대상포진	바이러스가 신경 안에서 증식하며 신경을 먼저 자극한다
어릴 때부터 계속	아토피 피부염	피부 장벽의 구조적 문제라 만성으로 간다

6-2. L – 세 단계로 경로를 그려요

이 CC에서 가장 무거운 항목이에요. 한 번에 묻지 말고 세 번에 나눠서 물어요.

I 위치 · 경로 MUST

어디에서 처음 생겼나요? 어디로 퍼졌나요? 그럼 지금 현재 어디어디에 발진이 있나요?

발진의 진행 경로가 곧 기전이에요. 세 단계를 시간 순서로 받아야 경로가 그려져요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
몸통 중심에서 팔다리로	바이러스 발진 · 성홍열	혈류를 타고 온 것이라 굵은 혈관 주변에서 먼저 반응한다
한쪽에 띠처럼	대상포진	신경절 하나에서 깨어나 그 신경이 담당하는 구역에만 나온다
닿은 자리에만	접촉피부염	원인 물질이 퍼지지 않으니 병변도 접촉면을 따라간다
팔오금 · 무릎 뒤	아토피 피부염	땀이 고이고 마찰이 반복되는 굽힘쪽이 주 무대다
손바닥 · 발바닥까지	2기 매독	전신 혈행성 파종의 특징적 분포다
사타구니 · 겨드랑이 · 손가락 사이	옴	각질층이 얇고 따뜻하며 습한 곳을 진드기가 좋아한다
땀 많이 나는 가슴 · 등	어루러기	피지와 땀이 많은 부위에 진균이 자란다
팔꿈치 · 무릎 · 두피	건선	마찰과 자극을 받는 편쪽이 호발 부위다

6-3. D · Co · Ex

D 지속 · 빈도 · 밤낮 SHOULD

발진이 생기면 얼마나 오래 가나요? 얼마나 자주 생기나요? 하루 중 밤낮에 변화가 있나요?

지속시간이 두드러기를 가르고, 밤낮 변화가 옴을 지목해요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
몇 시간 내 사라졌다 다시	두드러기	팽진은 혈관 투과성 변화라 빠르게 생겼다 사라진다
밤에 유난히 가렵다	옴 · 아토피	진드기가 밤에 활동적이고, 체온이 오르면 가려움 역치가 낮아진다
계속 남아 있다	만성 피부 질환	구조적 변화가 있으면 지속된다
주기적으로 반복	접촉 · 음식 알레르기	노출이 반복될 때마다 반응이 재현된다

Co 진행 SHOULD

점점 더 크거나 부위가 커지나요? 개수가 늘어나나요? 가려움이나 통증이 더 심해지나요?

진행 속도가 급성 감염과 만성 질환을 갈라요. 빠르게 번지면 감염이나 약물 반응을 위로 올려요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
빠르게 번진다	감염 · 약물 발진	원인이 계속 공급되거나 증식하고 있다
천천히 넓어진다	건선 · 어루러기	만성 경과를 따르는 질환이다
가려움이 심해진다	알레르기 · 옴	면역 반응이 강해지거나 진드기가 늘고 있다
변화 없다	만성 안정기	급성 원인보다 만성 질환을 본다

Ex 이전 삽화 · 치료 SHOULD

이전에도 이런 적이 있나요? 이전에 피부과 치료를 받은 적이 있나요?

반복 여부가 만성 질환과 알레르기를 시사하고, 치료 반응이 진단 정보가 돼요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
전에도 같은 자리에	고정 약진	그 부위에 기억 T세포가 남아 같은 자리에서만 반응한다
어릴 때부터 반복	아토피 피부염	피부 장벽의 구조적 문제라 평생 반복된다
스테로이드 연고에 좋아졌다	염증성 · 알레르기성	약물 반응성이 간접 근거가 된다
처음이다	급성 원인	새로 생긴 노출이나 감염을 찾는다

6-4. C – 병변의 생김새를 받아요

C 양상 – 복숭아 MUST

발진 모양이 어떤가요? 과녁 모양은 아닌가요? 몇 개나 되고 크기와 색깔은 어떤가요? 딱지가 앉거나 물집이 잡히거나 흰 비늘 같은 것이 덮이지는 않나요? 발진 여러 개가 하나로 합쳐지기도 하나요?

원발진과 이차 변화를 한 번에 받아요. 수 · 크기 · 색깔 · 모양이 기본이고 딱지 · 물집 · 비늘이 추가예요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
과녁 모양	다형홍반 · SJS/TEN 초기	중심과 주변의 반응 정도가 달라 동심원 모양이 된다
물집이 잡힌다	대상포진 · 수두 · 천포창 · SJS/TEN	표피 안이나 아래에 액체가 고인 상태다
은백색 비늘이 겹겹이	건선	각질 형성이 비정상적으로 빨라 층층이 쌓인다
딱지가 앉는다	이차 변화 · 감염 · 긁은 자국	수포나 미란이 마르면서 생긴다
얼룩덜룩한 흰색 · 갈색 반점	어루러기	진균이 색소 생성에 영향을 준다
여러 개가 합쳐진다	판 형성 · 건선 · 만성 습진	구진이 융합해 넓은 판이 된다

C 동반 – HIT MUST

만지면 뜨거운가요? 가렵거나 따갑지는 않나요? 눌렀을 때 아픈가요? 일상 생활에 많이 불편하신가요?

열감 · 가려움 · 압통 셋을 한 번에 받아요. 따가움은 가려움과 같이 물어요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
가렵다	알레르기 · 옴 · 아토피	히스타민을 비롯한 매개물질이 가려움 신경을 자극한다
아프다 · 따갑다	대상포진 · 감염 · SJS/TEN	신경 침범이나 조직 손상이 있으면 통증이 앞선다
만지면 뜨겁다	감염 · 급성 염증	혈류 증가가 열감으로 느껴진다
아무 증상 없다	어루러기 · 색소 변화	염증 반응이 약하면 증상이 거의 없다

6-5. A – 대축을 판정하는 네 줄

A 전신 MUST

열이나 오한, 감기 기운은 없으신가요? 식은땀이나 근육통, 관절통은요?

전신 증상의 유무가 대축을 갈라요. 있으면 전신 질환, 없으면 피부 자체 질환 쪽이에요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
발열 · 감기 증상	바이러스 발진 · 성홍열 · 2기 매독	감염이 전신 반응을 만든다
근육통 · 관절통	자가면역 · 감염	전신 염증이 근육과 관절에도 영향을 준다
전신 증상 없음	피부 자체 질환	국소 원인이면 전신 반응이 생길 이유가 없다
고열 + 아파 보임	중증 감염	관문에서 즉시 걸러야 하는 상황이다

A 감염 계통 SHOULD

오심이나 구토, 설사는 없으신가요? 숨이 차거나 기침, 가래, 인후통은요?

감염의 진입 경로와 침범 장기를 훑어요. 인후통과 구토는 성홍열을 지목해요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
인후통 · 구토	성홍열	인두에 자리 잡은 균이 독소를 내보낸다
기침 · 가래	호흡기 감염 동반	바이러스 발진의 선행 증상일 수 있다
설사	장관 감염 · 반응성	감염원의 경로를 시사한다
호흡곤란	아나필락시스 · 중증	관문으로 즉시 올린다

A 류마티스 MUST

관절이 아프지는 않나요? 햇빛에 노출된 부위에 발진이 잘 생기나요? 소변에 거품이 많거나 입 안, 성기가 헐지는 않나요? 팔다리 힘이 약해지지 않았나요?

전신 자가면역을 걸러내는 줄이에요. 광과민 · 거품뇨 · 궤양 · 근력 약화 넷을 한 번에 물어요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
햇빛 보면 심해진다	전신홍반루푸스	자외선이 각질세포를 죽여 핵 항원을 노출시킨다
소변에 거품	루푸스 신염	사구체 침착으로 단백뇨가 생긴다
구강 · 성기 궤양	베체트 · 루푸스	점막 침범이 있는 전신 질환이다
머리 빗기 · 계단 오르기가 힘들다	피부근염	근위부 근력이 먼저 약해진다
관절통	자가면역 질환군	피부와 관절을 함께 침범하는 질환이 많다

A 알레르기 MUST

입술이 붓거나 숨쉬기가 힘들지는 않으셨나요?

아나필락시스를 거르는 줄이에요. 짧지만 관문 항목이라 반드시 던져요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
입술이 부었다	혈관부종 · 아나필락시스 위험	점막 부종은 기도 폐쇄로 갈 수 있다
숨이 차고 어지러웠다	아나필락시스	전신 혈관 확장과 기관지 수축이 동시에 온다
없다	즉시형 반응 근거 약함	다만 교육에서 응급 증상을 반드시 알려준다

6-6. F – 유발 인자를 네 방향으로

F 악화 · 완화 MUST

언제 발진이 더 심해지나요? 어떻게 하면 좀 사라지나요? 발진이 나기 전에 그 부분에 새로운 비누나 화장품, 로션이나 새로운 옷이 닿지는 않았나요?

접촉피부염을 직격하는 질문이에요. 원인 회피가 곧 치료라 유발 인자를 찾는 게 핵심이에요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
새 화장품 · 비누 · 옷	접촉피부염	감작된 물질에 다시 노출되면 그 자리에서 반응한다
금속 장신구	접촉피부염	니켈 같은 금속이 흔한 원인이다
땀 흘리면 심해진다	콜린성 두드러기 · 아토피	체온 상승이 매개물질 분비를 유발한다
찬물에 닿으면	한랭 두드러기	온도 변화가 비만세포를 자극한다
보습하면 좋아진다	아토피 · 건조 습진	장벽 회복이 증상을 줄인다

F 음식 · 성관계 SHOULD

발진이 나기 전에 어떤 음식을 드셨나요? 최근에 처음 만난 사람과 성관계를 한 적이 있나요?

음식 알레르기와 2기 매독을 각각 겨냥해요. 성관계 질문은 양해를 구하고 물어요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
특정 음식 후 반복	음식 유발 두드러기	같은 음식에 반복 노출될 때마다 재현된다
위험한 성관계	2기 매독	외음부 궤양 병력이 없어도 2기로 올 수 있다
해당 없음	해당 원인 배제	다른 유발 인자로 초점을 옮긴다

6-7. E · 외 · 과 · 약 · 사 · 가 · 여

과 알레르기 과거력 MUST

알레르기 천식이나 비염, 아토피 피부염이 있나요? 특정 음식이나 꽃가루, 동물 알레르기가 있나요? 최근에 감기에 걸린 적이 있나요?

아토피 소인을 확인해요. 비염 · 천식 · 아토피는 같은 소인을 공유하므로 사전 확률이 크게 올라가요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
비염이나 천식이 있다	아토피 피부염	같은 알레르기 소인을 공유한다
특정 알레르기가 있다	알레르기성 발진	노출 경로를 특정할 수 있다
최근 감기	바이러스 발진	선행 감염이 발진의 원인일 수 있다
없다	아토피 소인 약함	다른 방향으로 초점을 옮긴다

약 약물 MUST

현재 복용하시는 약물이 있나요? 최근 새롭게 먹는 약이나 건강보조식품은 있나요? 약물을 중단하면 좋아지나요?

약물 발진을 직격해요. 건강보조식품까지 물어야 하고, 중단 후 반응이 진단이자 치료예요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
최근 새 약을 먹었다	약물 발진	지연형 반응이라 며칠 뒤 발진이 나온다
건강보조식품을 시작했다	약물 발진	환자가 약으로 인식하지 않아 묻지 않으면 안 나온다
중단하니 좋아졌다	약물 발진 확진에 가까움	원인 제거로 반응이 멈춘 것이다
복용 약 없음	약물 원인 배제	다른 유발 인자를 찾는다

사 생활 · 노출 SHOULD

음주나 흡연은 하세요? 직업이 어떻게 되세요? 최근에 여행 다녀오신 곳 있으신가요? 벌레 물린 곳이 있나요?

감염과 노출 경로를 잡아요. 여행력과 벌레 물림은 묻지 않으면 안 나오는 정보예요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
최근 여행	감염성 발진	지역 특이 감염에 노출되었을 수 있다
벌레에 물렸다	벌레 물림 반응 · 감염 매개	물린 자리를 중심으로 병변이 생긴다
화학물질을 다루는 직업	접촉피부염	직업성 노출이 반복된다
특이사항 없음	노출 경로 불명	다른 항목으로 좁힌다

가 가족력 MUST

가족 중에도 지금 비슷한 증상을 호소하는 분이 있나요? 가족 중에 천식이나 비염, 아토피 피부염, 알레르기 질환을 앓고 계신 분이 있나요?

두 가지를 동시에 물어요. 동시 발생은 옴이나 전염성 질환을, 알레르기 가족력은 아토피를 지목해요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
가족도 같이 가렵다	옴 · 전염성 질환	밀접 접촉으로 옮기기 때문에 동시에 발생한다
알레르기 가족력	아토피 피부염	알레르기 소인은 가족 집적성이 뚜렷하다
없다	전염성 · 유전 소인 약함	개인 노출이나 다른 원인을 본다

여 월경 · 성 관련 DROP

월경은 규칙적으로 하세요? 생리량에 변화가 없나요? 질분비물이 많아졌나요? 성관계 시 통증이 있나요?

항목표에 있으니 시간이 되면 물어요. 매독이나 성병 방향에서만 의미가 커져요.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 갈리는 이유
질분비물이 늘었다	성매개감염 동반	2기 매독이나 다른 성병을 함께 본다
성관계 시 통증	성기 병변	베체트나 성병의 국소 병변을 시사한다
특이사항 없음	정보 없음	감별에 추가 정보를 주지 않는다

E 건강검진 · 외 수술 DROP

이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요? 수술 받은 적 있으세요?

이 CC에서 감별을 좁히지 못해요. 가장 먼저 자릅니다.

환자의 답	가리키는 것	그렇게 걸리는 이유
특별한 건 없었다	정보 없음	예상되는 가장 흔한 답이다
면역억제 상태	대상포진 · 중증 감염	드물지만 나오면 방향을 크게 바꾼다

스스로 답해보기

- Q L을 왜 세 단계로 나눠 묻는가? 각 단계가 무엇을 말해 주는가?
- Q 약 항목에서 건강보조식품까지 묻는 이유는?
- Q 가족력을 두 방향으로 묻는 이유는?

PART 7

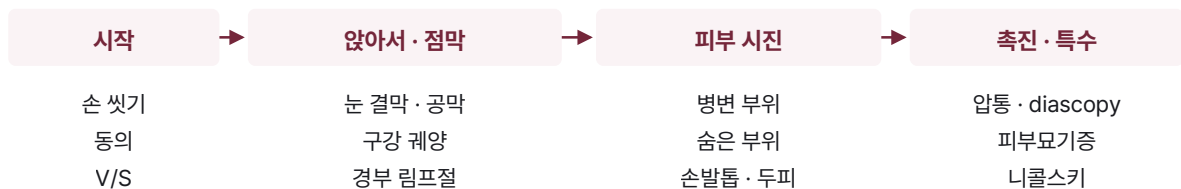
Physical examination

발진은 보는 CC예요. 그런데 **환자가 인지하지 못한 곳을 찾는 게** 채점의 핵심이에요.

발진은 SP에게 분장으로 재현되어 있어요. 그러니 대충 보고 넘어가면 그 자리에서 점수가 빠져요. 그리고 **옷과 장신구로 가려진 부위까지 완전 노출을 요청**해야 해요. 두피, 손발톱, 겨드랑이, 사타구니처럼 환자가 미처 못 본 자리에 답이 있는 경우가 많거든요.

누르기 전에는 반드시 양해를 구해요. **제가 한번 눌러보겠습니다. 아프면 말씀하세요.** 이 한 문장이 채점 항목이에요.

7-1. 동선



이 동선의 함정

상의를 벗기고 옷 · 장신구로 가려진 부위까지 완전 노출을 요청한다
환자가 인지하지 못한 곳에 발진이 있는지가 채점 항목이다
누르기 전에는 반드시 양해를 구한다 - 제가 한번 눌러보겠습니다

점막 먼저, 그 다음 피부 전신 사진, 마지막에 촉진과 특수검사

- 시작**
손 씻기 › 진찰 동의 › 활력 징후 언급.
- 앉아서 · 눈**
결막과 공막을 봐요. 점막 침범은 심각도를 한 단계 올려요.
- 앉아서 · 구강**
궤양을 확인해요. 베체트 · 루푸스 · SJS/TEN이 걸려요.
- 앉아서 · 목**
경부 림프절을 촉진해요. 감염을 시사해요.
- 앉아서 · 피부 사진**
발진 부위와 전신을 봐요. 눈 · 코 · 구강 · 머리카락 사이 · 팔다리 · 손톱 · 발톱, 그리고 **상의를 벗겨 몸통 전체**를 사진해요.
- 앉아서 · 발진 성상**
고름이나 딱지가 있는지, 이차 병변(삼출물 · 농 · 비늘 · 태선화)이 있는지 확인해요.
- 촉진**
양해를 구하고 눌러 **홍반과 자반을 구별**해요.
- 특수검사**

아토피가 의심되면 설압자로 긁어 **피부묘기증**, 수포성 병변이 있으면 **니콜스키 징후**를 확인해요.

9 상황부

류마티스 질환이 의심되면 흉부 심음 · 호흡음 청진과 관절 시진 · 촉진 · ROM 검사를 추가해요.

10 마무리

협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

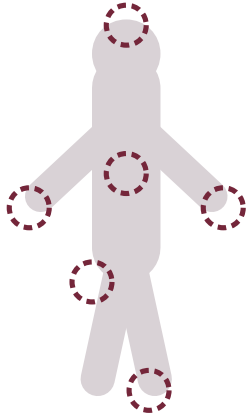
7-2. 진찰마다 무엇을 잡나

진찰	무엇을 보는가	지목하는 질환
눈 결막 · 공막	충혈 · 병변	SJS/TEN · 베체트 포도막염
구강	궤양	베체트 · 루푸스 · SJS/TEN
경부 림프절	비대 · 압통	감염 · 바이러스 발진
발진 위치 시진	분포와 대칭성	일측 띠 = 대상포진 / 굽힘쪽 = 아토피 / 접촉면 = 접촉피부염
발진 모양 시진	원발진과 이차 변화	비늘 = 건선 / 수포 = 대상포진 · 천포창 / 자반 = 혈관염
손발톱 · 두피	함몰 · 변형 · 비늘	건선
촉진 · diascopy	눌러서 하얘지는가	안 하얘지면 자반 · 혈관염 · 혈소판 이상
피부묘기증	긁은 자리가 부풀어 오르는가	아토피 · 두드러기 성향
니콜스키 징후	표피가 밀려 벗겨지는가	SJS/TEN · 천포창

7-3. 특이검사 카드

전신 피부 시진 Full skin survey

FULL SKIN SURVEY · 전신 피부 시진



두피 · 눈 · 코 · 구강 주변

겨드랑이 · 사타구니 등 접히는 곳

손톱 · 발톱

손바닥 · 발바닥 – 2기 매독

상의를 벗고 장신구도 빼 달라고 요청

양성

환자가 말하지 않은 부위에
발진이 있을 때

1 위에서 아래로 빠짐없이

흔한 실수 · 환자가 가리킨 자리만 보고 끝내는 것

2 가려진 자리는 노출 요청

환자 자세 · 준비

앉아서. 상의를 벗고 가려진 부위까지 노출을 요청해요.

내 손동작

1. 윗옷을 벗어 주시겠어요 하고 양해를 구해요.
2. 머리카락 사이 두피부터 시작해 눈 · 코 · 구강 주변을 봐요.
3. 몸통 앞뒤, 겨드랑이, 사타구니처럼 접히는 부위를 봐요.
4. 팔다리와 손톱 · 발톱을 확인해요.
5. 장신구가 가린 자리는 잠시 빼 주시겠냐고 요청해요.

양성 판정

환자가 말하지 않은 부위에 발진이 있으면 진단이 크게 바뀔 수 있어요. 손바닥과 발바닥까지 봤다면 2기 매독을 잡을 수 있고요.

무엇을 잡나

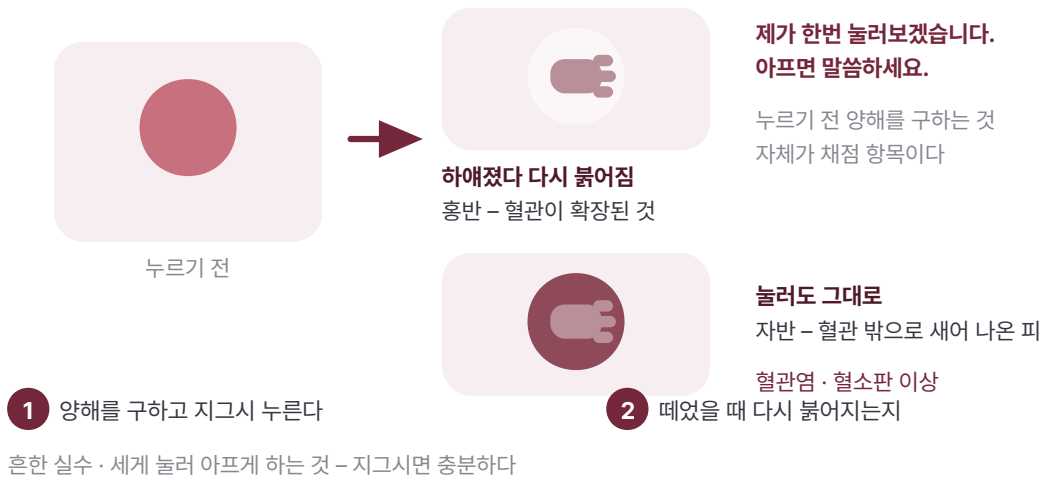
발진은 병변 하나가 아니라 **분포**가 진단을 만들어요. 전신을 봐야 분포가 보입니다.

흔한 실수

환자가 가리킨 자리만 보고 끝내는 것. 그리고 상의 탈의를 요청하지 않아 몸통을 못 보는 것.

압통 촉진 · 홍반 · 자반 구별 Palpation / Diascopy

DIASCOPY · 홍반 · 자반 구별



환자 자세 · 준비

앉아서. 누르기 전에 반드시 양해를 구해요.

내 손동작

1. 제가 한번 눌러보겠습니다, 아프면 말씀하세요 하고 양해를 구해요.
2. 손가락이나 투명한 유리로 병변을 지그시 눌러요.
3. 누른 상태에서 색이 하얘지는지 봐요.
4. 떼었을 때 다시 붉어지는지 확인해요.
5. 동시에 압통이 있는지 물어요.

양성 판정

눌러서 하얘졌다가 떼면 붉어지면 **홍반**이에요. 눌러도 그대로면 **자반**이고, 혈관 밖으로 피가 나온 상태예요.

무엇을 잡나

혈관 안의 피는 눌리면 밀려나고, 혈관 밖으로 새어 나온 피는 밀 곳이 없어요. 이 단순한 물리가 전신 질환을 지목합니다.

흔한 실수

양해를 안 구하고 누르는 것. 그리고 세게 눌러 환자를 아프게 하는 것. 지그시 누르면 충분해요.

피부묘기증 Dermographism

DERMOGRAPHISM · 피부묘기증



팔 안쪽을 뭉툭한 것으로 한 줄 긁는다

1~3분 기다린다

양성

그은 자리를 따라
붉게 부풀어 자국이 남을 때

긁는 자극에 비만세포가 반응해
히스타민이 나오고 팽진이 생긴다

1 설압자로 한 줄

흔한 실수 · 기다리지 않고 바로 판정하거나, 세게 그어 상처를 내는 것

2 1~3분 뒤 판정

환자 자세 · 준비

앉아서. 아토피나 두드러기가 의심될 때.

내 손동작

1. 설압자나 펜 뚜껑 같은 뭉툭한 것을 준비해요.
2. 팔 안쪽 피부를 적당한 힘으로 한 줄 그어요.
3. 1~3분 정도 기다려요.
4. 그은 자리가 어떻게 변하는지 봐요.

양성 판정

그은 자리를 따라 붉게 부풀어 올라 자국이 남으면 양성이에요.

무엇을 잡나

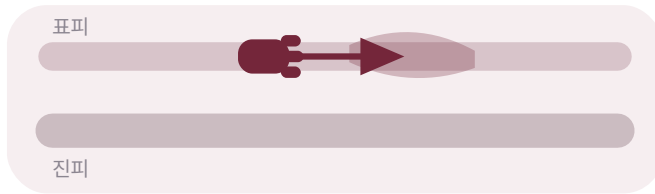
긁는 자극에 비만세포가 반응해 히스타민이 나오고, 그 자리에 국소 팽진이 생겨요. 피부가 과민한 상태라는 뜻입니다.

흔한 실수

너무 약하게 그어 반응이 안 나오거나, 너무 세게 그어 상처를 내는 것. 그리고 기다리지 않고 바로 판정하는 것.

니콜스키 징후 Nikolsky sign

NIKOLSKY SIGN · 니콜스키 징후



겉보기 정상 피부를 옆으로 지그시 민다

양성

표피가 밀려
박리될 때

표피와 진피 사이의 결합이
파괴되어 있으면 층이 분리된다
SJS / TEN · 천포창

1 수포성 병변이 있을 때만

흔한 실수 · 세게 밀어 멀쩡한 피부를 벗기는 것

2 면봉으로 옆으로 민다

환자 자세 · 준비

앉아서, 수포성 병변이 있을 때만.

내 손동작

1. 병변 주변의 겉보기 정상 피부를 고릅니다.
2. 면봉이나 손가락으로 표피를 옆으로 지그시 밀어 봐요.
3. 표피가 밀려나며 벗겨지는지 확인해요.

양성 판정

표피가 밀려 박리되면 양성이에요. SJS/TEN이나 천포창을 강하게 시사해요.

무엇을 잡나

표피와 진피 사이 또는 표피 안의 결합이 파괴되어 있으면 옆으로 미는 힘에 층이 분리돼요.

흔한 실수

수포가 없는데 시행하는 것. 그리고 세게 밀어 멀쩡한 피부를 벗기는 것. 지그시 미는 정도면 충분해요.

7-4. 감점 포인트

- 상의 탈의를 요청하지 않아 몸통 전체를 못 봄
- 환자가 가리킨 자리만 보고 숨은 부위를 안 살핌
- 누르기 전에 양해를 구하지 않음
- 흉반과 자반을 구별하지 않음. 눌러 보는 것만으로 방향이 바뀌어요
- 점막(눈 · 구강)을 확인하지 않음. 심각도 판정의 첫 단계예요
- 수포가 있는데 니콜스키 징후를 확인하지 않음
- 아토피가 의심되는데 피부요기증을 확인하지 않음
- 손발톱과 두피를 건너뛴. 건선의 단서가 거기 있어요
- 류마티스가 의심되는데 관절과 심폐 진찰을 추가하지 않음

– 손 씻기 · 진찰 동의 · V/S 언급 누락

스스로 답해보기

Q 눌러서 하얘지는지 보는 것만으로 왜 방향이 바뀌는가?

Q 니콜스키 징후는 언제 시행하고, 양성이면 무엇을 의심하는가?

PART 8

검사 계획

원인을 찾아 피하는 게 치료라, 검사도 원인 규명에 맞춰져 있어요.

검사	왜 · 언제	근거
접촉검사 Patch test	접촉피부염. 의심 물질 부착 후 2일째와 4일째 판독해요	[GL]
의심 약물 사용 금지	약물 발진. 중단 후 반응을 보는 것이 진단이자 치료예요	[GL]
혈액검사	CBC, serum IgE level, ESR, CRP, ANA	[GL]
미생물검사	우드등검사, KOH test, Tzanck smear, Gram stain, culture	[GL]
skin prick test	아토피 피부염에서 원인 알레르겐을 찾을 때	[상황부]
VDRL · TPHA · FTA-ABS	위험한 성관계 병력이 있고 전신 발진일 때	[상황부]
항핵항체 · anti-dsDNA	광과민 · 구강 궤양 · 관절통 · 거품뇨가 있을 때	[상황부]
EMG · CK · 근육조직검사	근위부 근력 약화가 있을 때(피부근염)	[상황부]
피부조직검사	임상으로 진단이 안 될 때. 건선 · 수포성 질환	[상황부]
편도 · 인두 검체 균 배양	성홍열이 의심될 때	[상황부]
점막 침범이 있는데 단순 약진으로 처리	SJS/TEN을 놓치는 경로예요	[금기]

8-1. 치료의 세 축

복용 중인 약물 중단 약이 원인이면 이게 첫 치료예요. **1**

원인 물질 회피 접촉이든 음식이든 노출을 끊는 게 근본 치료예요. **2**

항히스타민 · 스테로이드제 · 보습제 증상을 끄고 장벽을 회복시켜요. **3**

진단	치 료
홍역 · 수두	대증 치료, 성인 수두는 항바이러스제
2기 매독	Benzathine penicillin
대상포진	항바이러스제, 대증요법(NSAID, Opioid, 항우울제, 항경련제)
옴	가족 동시 치료, 퍼메트린 연고(얼굴 제외, 8시간 후 씻어냄)
어루러기	건조하고 시원한 환경 유지, 국소항진균제
성홍열	항생제

진단	치료
건선	국소 스테로이드, 광선 치료, Retinoid
접촉피부염	냉습포, 국소 스테로이드, 국소면역조절제, 항히스타민제
약진	약 중단 후 국소 스테로이드. 전신 증상이 있으면 전신 스테로이드
SLE	NSAIDs, Prednisolone, Hydroxychloroquine
베체트	Colchicine, Glucocorticoid, Infliximab
아토피	항히스타민제, 피부 보습, 국소 스테로이드

PART 9

Education

이 CC는 교육이 무거워요. 일상 관리가 치료의 큰 부분이거든요.

9-1. 교육 대사의 뼈대

단계

말할 문장

공감	갑자기 피부에 발진이 나 많이 놀라셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지 문진과 신체 검진을 해본 결과 가려움을 동반한 발진이 보이는데, 원래 알레르기 비염이 있으셨고 가족력도 있으셔서 아토피 피부염의 가능성이 가장 높습니다.
감별 진단	그러나 최근에 감기약을 드셨기 때문에 약물에 의한 발진일 수도 있고, 최근에 모르는 분과 성관계를 하셨다는 점에 서 매독에 의한 피부 반응일 수도 있습니다.
검사	아토피 피부염은 원인 물질을 피하는 것이 가장 좋은 치료이기 때문에 원인을 찾기 위해 피부바늘따끔검사와 혈액검사를 해보겠습니다. 또한 매독검사도 진행해 보도록 하겠습니다. 괜찮으신가요?
치료	아토피 피부염은 검사 후에도 원인 물질을 알기가 힘든 경우가 많아 치료가 오래 지속될 수 있습니다. 치료에서 가장 중요한 것은 피부 청결과 보습입니다. 건조해지지 않도록 보습제를 충분히 발라 주시고, 평소에 꽉 조이는 옷은 피해주세요. 어려우시겠지만 가려워도 최대한 긁지 말아주세요.
예후	잘 치료를 받으시면 증상이 많이 좋아지실 것입니다.
응급	갑자기 숨을 잘 못 쉬겠거나 어지럽고 가슴이 두근거리는 등의 증상이 발생하면 빨리 병원에 오셔서 응급 조치를 받으셔야 합니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

9-2. 아토피 피부염 생활 관리

교육

왜 이렇게 말하나

외부 온도와 습도의 급격한 변화를 피한다	장벽이 약해 환경 변화에 바로 반응해요
심한 운동과 더운 목욕은 피한다	땀이 나면 가려워지고 긁기 고리가 시작돼요
중성 비누로 씻고, 물기를 말린 뒤 보습제를 충분히	씻는 것이 자극이 되지 않게 하고, 빠진 지질을 채워 벽을 메워요
피부 자극이 없고 땀을 잘 흡수하는 면제품 의류	마찰과 땀 정체가 둘 다 악화 요인이예요
피부염을 악화시키는 음식과 환경을 피한다	회피가 곧 치료라 유발 인자를 아는 게 중요해요
정신적 스트레스를 피한다	스트레스가 가려움 역치를 낮춰요
긁지 않아야 한다	2차 세균 감염과 흉터가 남고, 긁기 고리가 계속 돌아요
생후 6개월 이내 모유수유	아토피 피부염 예방에 도움이 돼요

교육

왜 이렇게 말하나

경과 설명

성장하면서 대부분 호전되지만 성인 이후까지 지속될 수도 있고, 성인기에
는 증상이 더 심해지기도 해요

9-3. 공통 생활교육 네 줄

병변을 자극하지 않기 긁지 말고, 로션 등 보습제를 발라 촉촉하게 유지해요. 1

원인 물질 회피 약이 원인이면 중단 후 반응을 확인해야 함을 설명해요. 2

아나필락시스 교육 증상 발생 시 에피네프린 등 응급 조치가 필요함을 강조해요. 3

류마티스 질환일 경우 추가적인 검사가 필요함을 설명해요. 4

9-4. 이런 증상이면 즉시 오세요

숨을 잘 못 쉬겠거나 어지럽고 가슴이 두근거릴 때 최우선

입술이나 혀가 붓고 목이 조이는 느낌이 들 때

입 안, 눈, 성기에 물집이나 혈음이 생길 때

피부가 넓게 벗겨지거나 고열이 함께 날 때

9-5. PPI 대사 뱅크

상황

준비 문장

오프닝

갑자기 발진이 나서 많이 놀라셨겠어요. 천천히 말씀해 주세요.

경로 확인

처음에 어디에 났고, 그 다음 어디로 번졌는지 순서대로 말씀해 주시겠어요?

탈의 요청

발진을 자세히 보려면 옷을 벗어 주셔야 합니다. 괜찮으실까요?

가려진 부위

목걸이나 시계를 잠시 빼 주시겠어요? 가려진 부위도 확인해야 해서요.

촉진 전

제가 한번 눌러보겠습니다. 아프면 말씀하세요.

민감한 질문 전

혹시 불편하시겠지만 진단에 꼭 필요해서 여쭙겠습니다.

긁지 말라고 할 때

어려우시겠지만 가려워도 최대한 긁지 말아주세요. 긁으면 더 가려워지는 악순환이 생깁니다.

오래 간다고 할 때

치료가 오래 걸릴 수 있지만 관리만 잘 하시면 증상은 충분히 조절됩니다.

클로징

제가 말씀드린 것 중에 더 궁금하신 점 있으실까요?

PART 10

케이스 통합 연습

10-1. 케이스 A – 피부 자체 질환

환자

스물네 살 여자입니다. 사흘 전 새 목걸이를 하고부터 목에 발진이 났어요.

목걸이가 닿는 자리만 딱 붉어지고 가렵습니다.

열은 없고 몸 다른 곳은 괜찮아요.

어릴 때부터 비염은 있었어요.

① 관문

점막 침범 없음, 입술 부종 없음, 발열 없음, 자반 아님. **응급 넷이 전부 지워져요.**

② 대축

전신 증상이 없고 병변이 국소예요. **피부 자체 질환 칸.** 경계가 뚜렷하고 접촉면을 따라간다는 게 접촉피부염을 지목해요.

③ 결정적 추가 문진

항목	질문	의미
L	처음 위치 · 퍼짐 · 현재	닿은 자리에 국한됨을 확정
F 접촉	새 물건 · 화장품 · 옷	원인 물질을 특정
Ex	이전에도 같은 상황	감작 여부와 반복성
과 · 가	비염 · 천식 · 알레르기 가족력	아토피 소인. 감별에 필요
A 전신	발열 · 관절통	전신 질환 배제

④ 진찰과 계획

눈 · 구강 점막 확인 › 상의 노출하고 전신 시진(다른 곳에도 있는지) › 병변 경계와 모양 › 양해 구하고 촉진(홍반 확인) › 아토피가 의심되면 피부묘기증. 검사는 **채포검사**. 교육은 원인 회피, 냉습포, 국소 스테로이드, 보습.

점수를 만든 지점 – L을 세 단계로 물어 국소 분포를 확정한 것, F에서 새 물건을 특정한 것, 전신 시진으로 다른 부위를 확인한 것.

10-2. 케이스 B – 전신 질환의 피부 발현

환자

서른한 살 여자입니다. 두 달 전부터 얼굴 광대 쪽에 발진이 있어요.

햇빛을 보면 더 심해집니다.

입 안이 자주 헐고 손목 관절이 아파요.

요즘 소변에 거품이 많이 납니다.

㉠ 관문

수포 없음, 입술 부종 없음, 고열 없음. 응급은 아니지만 **점막 궤양이 있어요**. 이것만으로 전신 질환 쪽 무게가 커집니다.

㉡ 대축

광과민 + 구강 궤양 + 관절통 + 거품뇨. **전신 질환의 피부 발현 칸**. 피부만 치료해서는 아무 소용이 없는 케이스예요.

㉢ 결정적 추가 문진

항목	질문	의미
A 류마티스	광과민 · 거품뇨 · 궤양 · 근력	네 가지가 대축을 확정
A 전신	발열 · 근육통 · 관절통	전신 염증 확인
L	발진 분포	malar rash인지 discoid인지
여	유산력 · 월경	항인지질항체와 연결
약	복용 약물	약물 유발 루푸스 배제

㉣ 진찰과 계획

눈 · 구강 점막 > 경부 림프절 > 얼굴과 전신 피부 시진(광노출 부위 중심) > 촉진 > **류마티스 의심이므로 심음 · 호흡음 청진과 관절 시진 · 촉진 · ROM 추가**. 검사는 CBC · 항핵항체 · anti-dsDNA · 소변검사. 교육은 자외선 차단과 추가 검사의 필요성.

점수를 만든 지점 - A 류마티스 줄을 던져 전신 질환으로 방향을 튼 것, 거품뇨를 물어 신장 침범을 잡은 것, 관절과 심폐 진찰을 추가한 것.

두 케이스의 대비가 말해 주는 게 있어요. A는 **분포가**, B는 **관절 밖 증상들이** 진단을 만들었어요. 그리고 A는 피부 치료로 끝나지만 B는 피부만 치료하면 안 돼요. **대축을 먼저 정하는 이유가 이겁니다.**

PART 11

3속도 복습

11-1. 시험 직전 1분 압축표

질환	덩어리	결정 단서	진단	치료
바이러스 발진	전신·감염	발열, 감기 증상, 중심부 > 주변부	CBC, 혈청검사	대증 치료, 성인 수두는 항바이러스제
성홍열	전신·감염	3세 이상 소아, 고열, 인후통, 구토	임상 + 인두 배양	항생제
2기 매독	전신·감염	위험한 성관계, 전신 발진, 손발바닥	VDRL, TPHA, FTA-ABS	Benzathine penicillin
대상포진	피부·감염	일측성, dermatome, 통증이 2~3일 먼저	검사 불필요, 간혹 PCR	항바이러스제, 통증 조절
옴	피부·감염	밤에 심한 가려움, 사타구니·겨드랑이, 가족 동시	긁어서 현미경, 굴 확 인	가족 동시 치료, 퍼메트린
어루러기	피부·감염	땀 많은 부위, 얼룩덜룩한 흰·갈색 반점	우드등, KOH, 진균 배양	건조·시원한 환경, 국소항진균제
건선	피부·염증	은백색 비늘 겹겹이, 팔꿈치·두피, 손발톱	피부조직검사, 임상	보습, 국소 스테로이드, 광선, Retinoid
접촉피부염	피부·알레르기	닿은 자리에만, 경계가 뚜렷	접촉검사, 유발검사	냉습포, 국소 스테로이드, 항히스타민제
약물 발진	의인성	약 복용 며칠 뒤 전신, 고정 약진은 같은 자리	의심 약 중단, 첩포검사	약 끊고 스테로이드, 항히스타민제
아토피 피부염	피부·알레르기	가려움, 건조, 나이별 호발 부위, 알레르기 가족력	skin prick test, 혈청 IgE	보습, 국소 스테로이드, 항히스타민제
전신홍반루푸스	전신·자가면역	malar·discoïd rash, 광과민, 구강 궤양, 거품뇨	CBC, ANA, anti-dsDNA	국소 스테로이드, HCQ, Glucocorticoid
베체트병	전신·자가면역	구강 + 생식기 궤양, 포도막염, 관절염	Pathergy test	Colchicine, Glucocorticoid
피부근염	전신·자가면역	gotttron papule, heliotrope rash, 근위부 근력 약화	EMG, CK, 근육조직 검사	스테로이드, 면역억제제

11-2. 미니케이스

상황

답

접촉피부염 · 첩포검사(2일째 · 4일째 판독)

상황

답

새 화장품 쓴 자리에만 경계가 뚜렷하게 발진
의심 · 검사

한쪽 옆구리에 띠처럼 물집, 발진 전부터 아팠어요
의심 · 기전

대상포진 · 신경절에서 깨어나 그 신경을 타고 나와요

밤에 유난히 가렵고 가족도 가려워해요
의심 · 교육 핵심

옴 · 가족 동시 치료. 한 사람만 치료하면 서로 다시 옮아요

약 먹고 나흘 뒤 온몸에 발진, 입 안도 헐었어요
다음 행동

점막 침범 > **SJS/TEN 의심**. 니콜스키 확인하고 약 중단, 응급 대응

놀러도 안 하얘지는 붉은 반점이 다리에 있어요
무엇을 의미하나

자반 · 혈관 밖으로 피가 나온 상태. 혈관염 · 혈소판 이상을 봐요

다섯 살 아이, 고열 · 인후통 · 구토 후 전신 발진
의심 · 치료

성홍열 · 항생제. 인두 검체 균 배양으로 확인

땀 많이 나는 등에 얼룩덜룩한 반점, 안 가려워요
의심 · 검사

어루러기 · 우드등검사, KOH 도말

광대 발진 + 광과민 + 구강 궤양 + 거품뇨
의심 · 어느 칸

전신홍반루푸스 · 전신 질환의 피부 발현. 피부만 치료하면 안 돼요

11-3. Active recall

왜만 모았어요

- Q 왜 전신인가 피부인가가 대축이고, 원발진 형태는 보조축인가?
- Q 왜 L을 세 단계로 나눠 묻는가?
- Q 왜 아토피에서 보습제가 스테로이드만큼 중요한가?
- Q 왜 아토피는 나이에 따라 호발 부위가 바뀌는가?
- Q 왜 접촉피부염은 경계가 뚜렷한가? 오래 쓰던 물건도 원인이 될 수 있는 이유는?
- Q 왜 약물 발진은 며칠 뒤에 나타나는가?
- Q 왜 고정 약진은 같은 자리에 반복되는가?
- Q 왜 대상포진은 한쪽에만 띠처럼 생기고 통증이 먼저 오는가?
- Q 왜 옴은 밤에 심하고 가족을 동시에 치료해야 하는가?
- Q 왜 성홍열은 인후통이 먼저이고 3세 이상 소아에게 오는가?
- Q 왜 놀러서 하얘지는지 보는 것만으로 전신 질환을 지목할 수 있는가?
- Q 니콜스키 징후가 양성이면 무엇을 의심하고, 왜 위급한가?
- Q 왜 환자가 인지하지 못한 부위까지 시진해야 하는가?

PART 12

대본 전문

항목	말할 문장	등급
O	언제부터 피부에 발진이 났나요?	MUST
O	어떤 특별한 상황에서 발생했나요?	MUST
L	어디에서 처음 생겼나요?	MUST
L	어디로 퍼졌나요?	MUST
L	그럼 지금 현재 어디어디에 발진이 있나요?	MUST
D	발진이 생기면 얼마나 오래 가나요? 얼마나 자주 생기나요?	SHOULD
D	하루 중 밤낮에 변화가 있나요?	SHOULD
Co	점점 더 크기나 부위가 커지나요? 개수가 늘어나나요?	SHOULD
Co	증상(가려움 or 통증)이 더 심해지나요?	SHOULD
Ex	이전에도 이런 적이 있나요? 이전에 피부과 치료를 받은 적이 있나요?	SHOULD
C 양상	모양(과녁 모양은 아닌가요?) / 수 / 크기 / 색깔	MUST
C 양상	딱지 / 물집 / 흰비늘 같은 것이 덮지는 않는지	MUST
C 양상	발진 여러 개가 하나로 합쳐지기도 하나요?	SHOULD
C 동반	열감(H) / 가려움증(I) / 따가움 / 압통(T)	MUST
C 정도	일상 생활에 많이 불편하신가요?	SHOULD
A 전신	발열 / 오한 / 감기 기운 / 식은땀 / 근육통 / 관절통	MUST
A 감염	오심 / 구토 / 설사 / 호흡곤란 / 기침 / 가래 / 인후통	SHOULD
A 류마티스	관절통 / 햇빛 노출 부위에 피부 발진이 잘 생기나요?	MUST
A 류마티스	거품뇨 / 구강 궤양 / 성기 궤양 / 팔다리 근력 약화	MUST
A 알레르기	입술 부종	MUST
F	언제 발진이 더 심해지나요? 어떻게 하면 좀 사라지나요?	MUST
F 접촉피부염	발진이 나기 전에 그 부분에 새로운 비누나 화장품, 로션이나 새로운 옷이 닿지는 않았나요?	MUST
F 음식 알레르기	발진이 나기 전에 어떤 음식을 드셨나요?	SHOULD
F 콜린성 두드러기	찬물에 닿거나 땀을 흘리면 악화되나요?	SHOULD
F 2기 매독	최근에 처음 만난 사람과 성관계를 한 적이 있나요? (위험한 성관계)	SHOULD

항목	말할 문장	등급
E	이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?	DROP
외	수술 받은 적 있으세요?	DROP
과	알레르기 천식이나 비염, 아토피 피부염이 있나요?	MUST
과	특정 음식이나 꽃가루, 동물 알레르기가 있나요?	MUST
과	최근에 감기에 걸린 적이 있나요?	SHOULD
약	현재 복용하시는 약물이 있나요?	MUST
약	최근 새롭게 먹는 약이나 건강보조식품은 있나요?	MUST
약	(지금은 안 먹는다면) 약물을 중단하면 좋아지나요?	MUST
사	음주는 하세요? 흡연은 하세요?	SHOULD
사	직업이 어떻게 되세요?	SHOULD
사	최근에 여행 다녀오신 곳 있으신가요?	SHOULD
사	벌레 물린 곳이 있나요?	SHOULD
가	가족 중에도 지금 비슷한 증상을 호소하는 분이 있나요?	MUST
가	가족 중에 천식 / 비염 / 아토피 피부염 / 알레르기 질환을 앓고 계신 분이 있나요?	MUST
여 월경력	월경은 규칙적으로 하세요? 생리량에는 변화가 없나요?	DROP
여 월경력	질분비물이 많아졌나요? 성관계 시 통증이 있나요?	DROP

12-1. P/E 전문

구분	항목
도입	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다.
앉아서 1	눈 : 결막, 공막
앉아서 2	구강 : 궤양
앉아서 3	목 : 경부 림프절 촉진(감염)
상황부	류마티스 질환 의심 시 흉부 심음 / 호흡음 청진 및 관절 시진, 촉진(압통), ROM 검사
앉아서 4	피부 발진 : 발진 부위 및 전신 진찰
시진(위치/모양)	발진 부위 / 눈, 코, 구강, 머리카락 사이, 팔다리, 손톱, 발톱, 상의 탈의하여 몸통 모두 시진
발진(모양/분포)	고름이나 가피 여부, 2차적 병변 여부(삼출물, 농, 비늘, 태선화) 확인
촉진	erythema / petechia 구별 - 제가 한번 눌러보겠습니다. 아프면 말씀하세요.

구분	항목
특수검사	아토피 의심 시 설압자로 긁어서 피부묘기증 확인 / 수포성 병변 있는 경우 니콜스키 징후 확인(병변 표피 부위를 면봉으로 밀어 보아 표피 박리 여부 확인)
마무리	협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

12-2. keyword

문진 시 위치(처음 발생 위치 / 이후 퍼진 부위 / 현재 병소 위치) 확인하기

발진의 모양, 수, 크기, 색깔, 가려움증, 따가움, 압통 확인하기

피부의 일차적인 질환인지, 혹은 전신 질환에 의한 이차적인 병소인지 확인하기

신체 진찰 시 환자가 인지하지 못한 곳에도 발진이 있지는 않은지 확인하기

병변의 자극을 피하기 위해 중성 비누 사용하고, 보습을 충분히 하고 긁지 않도록 교육하기

유발 원인 찾아 없애도록 교육하기

부록

원본과 어긋난 지점 · 출처

지점	원본	이 가이드
감별 대축	피부의 일차적인 질환인지, 전신 질환에 의한 이차적인 병소인지 확인하라고 서술	이 문장을 그대로 단일 대축으로 삼았다. 원발진 형태(알고리즘의 blanching · purpura · serous · purulent)는 보조축으로 내렸다
응급의 위치	SJS/TEN은 알고리즘의 수포성 칸 안에 다른 질환들과 나란히 놓여 있다	아나필락시스 · 중증 감염 · 자반과 함께 대축 앞의 관문 으로 올렸다. 형태를 묘사하기 전에 먼저 지워야 하는 것들이기 때문
아나필락시스	문진의 A 알레르기 항목에 '입술 부종' 한 줄, 교육에 응급 조치 서술	관문 항목으로 승격시켰다. 입술 부종은 기도 폐쇄로 갈 수 있어 다른 항목보다 우선한다
특이검사 술기	피부묘기증과 니콜스키 징후의 이름과 판정만 제시	PART 7의 손동작 · 판정 · 기전 · 흔한 실수는 표준 술기를 풀어 쓴 것으로 원본에 명시된 내용이 아니다. 실습에서 확인할 것
소아 케이스	소아에서는 아토피 호발 부위 정도만 달라지고, 3세 이상 소아에서 호발하는 성홍열이 추가된다고 명시	그대로 따랐다. 성홍열을 루프로 돌리고, 아토피의 나이별 호발 부위를 3-1에서 설명했다
시간 예산	제시되지 않음	Hx 5분 / PEx 4분 / Edu 3분으로 제시했다 [관행]. 이 CC는 생활 관리 교육이 길어 Edu에 예산을 더 뒀다
Quick Sheet 대조	-	한글 단일 소스로 제작했다. Quick Sheet에만 있는 항목이 있다면 반영되지 않았다

출처: 『한 권으로 끝내는 CPX 총론』 27. 피부 발진(Skin rash), p.283~290.